

Depresión y suicidio en el anciano

1. Introducción y relevancia clínica

La **depresión en el adulto mayor** es un **trastorno del ánimo frecuente, subdiagnosticado y potencialmente letal**, caracterizado por ánimo bajo, pérdida de interés, enlentecimiento psicomotor y síntomas somáticos o cognitivos que interfieren con el funcionamiento diario.

En el anciano, la depresión **no siempre se manifiesta con tristeza**, sino con **apatía, fatiga, irritabilidad o quejas somáticas**. Se asocia a **alta morbilidad, discapacidad funcional y riesgo suicida elevado**.

Epidemiología

- **Prevalencia mundial:** 10–15% en población >65 años.
- **Chile:** cerca del **12%** de los adultos mayores presentan síntomas depresivos clínicamente relevantes (ENS 2020).
- **Tasa de suicidio:** los mayores de 70 años tienen las **tasas más altas de suicidio consumado** en Chile (Ministerio de Salud, 2023).

Relevancia clínica

- Es una de las causas más frecuentes de **consultas de salud mental en APS**.
- Puede ser el **primer signo de una demencia incipiente**.
- El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado **reducen la mortalidad y mejoran la calidad de vida**.

□ En **EUNACOM**, es común la presentación de un adulto mayor con “pérdida de apetito, insomnio, desinterés y lentitud”, en quien se debe reconocer una **depresión geriátrica** y descartar **suicidio o demencia**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La depresión en el adulto mayor resulta de una interacción entre **factores biológicos, psicológicos y sociales**, modulada por los cambios neuroquímicos del envejecimiento.

2.1. Factores biológicos

- **Disminución de neurotransmisores:** serotonina, noradrenalina y dopamina.
 - **Alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS):** aumento del cortisol, neurotoxicidad hipocampal.
 - **Cambios estructurales cerebrales:** atrofia frontotemporal, lesiones de sustancia blanca (isquemia subcortical).
 - **Enfermedades médicas crónicas:** HTA, diabetes, ECV, cáncer, EPOC, dolor crónico.
 - **Fármacos depresógenos:** betabloqueadores, benzodiacepinas, corticoides, digoxina, interferón.
-

2.2. Factores psicológicos

- Pérdidas significativas (duelo, independencia, roles sociales).
 - Aislamiento, sensación de inutilidad o desesperanza.
 - Alteración de la autoestima y sentido vital.
 - Vulnerabilidad a la “**depresión vascular**” (daño microangiopático cerebral que altera el circuito frontosubcortical del ánimo).
-

2.3. Factores sociales

- Soledad, institucionalización, pobreza, violencia o maltrato.
- Jubilación o pérdida de rol productivo.
- Baja participación comunitaria o familiar.

□ El envejecimiento cerebral reduce la resiliencia neuroquímica frente al estrés, facilitando la aparición de **síntomas depresivos ante eventos vitales menores**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas cardinales

La depresión en el anciano puede presentarse de forma **típica** o **atípica**:

Tipo	Manifestaciones predominantes
Típica	Tristeza, anhedonia, fatiga, culpa, alteraciones del sueño o apetito.
Atípica o enmascarada	Quejas somáticas, hipocondría, lentitud, irritabilidad, aislamiento social, deterioro cognitivo aparente.

En la práctica, los pacientes **no verbalizan tristeza**, sino **“no tengo ganas de nada”**, “todo me da lo mismo”, o “ya cumplí mi ciclo”.

3.2. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Se requiere la presencia de **≥5 síntomas durante al menos 2 semanas**, con **uno de los dos primeros obligatorios**:

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día.
2. Disminución del interés o placer (anhedonia).
3. Cambios en peso o apetito.
4. Alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia).
5. Fatiga o falta de energía.
6. Sentimientos de inutilidad o culpa.
7. Dificultad para concentrarse o indecisión.
8. Lentitud o agitación psicomotora.
9. Pensamientos de muerte o suicidio.

Los síntomas deben provocar **deterioro funcional** y **no explicarse por una enfermedad médica o duelo reciente**.

3.3. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Demencia	Curso progresivo, con pérdida objetiva de memoria; la atención suele preservarse.
Delirium	Inicio agudo y fluctuante; conciencia alterada.
Trastorno adaptativo	Síntomas leves tras evento vital, de duración <6 meses.
Depresión secundaria a enfermedad médica	Temporalmente asociada a patología o fármaco.
“Seudodemencia depresiva”	Olvido aparente con queja exagerada; mejora al tratar la depresión.

☐ En **EUNACOM**, la “seudodemencia” es una trampa frecuente: la depresión **imita una demencia**, pero mejora con antidepresivos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación clínica integral

- **Anamnesis detallada** y heteroanamnesis (familiar o cuidador).
 - **Evaluar funcionalidad:** actividades básicas (Barthel) e instrumentales (Lawton).
 - **Evaluar riesgo suicida:** ideación, plan, medios, desesperanza.
-

4.2. Instrumentos de tamizaje

- **Escala de Depresión Geriátrica (GDS-15):**

- Validada en Chile, fácil de aplicar.
 - Puntos de corte:
 - 0–4: normal
 - 5–8: leve
 - ≥9: depresión probable
 - **PHQ-9 (versión geriátrica):** útil en APS.
 - **Mini-Mental o MoCA** si hay síntomas cognitivos.
-

4.3. Exámenes complementarios

Para descartar causas médicas:

- Hemograma, glicemia, creatinina, electrolitos.
 - TSH, B12, ácido fólico.
 - ECG (si uso de antidepresivos tricíclicos).
 - TAC o RM cerebral si hay deterioro cognitivo reciente o focalidad neurológica.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo de la depresión geriátrica debe ser **multimodal, individualizado y multidisciplinario**, integrando psicoterapia, fármacos y apoyo social.

5.1. Psicoeducación y medidas generales

- Explicar que la depresión es **una enfermedad tratable**, no una debilidad.
- Involucrar a la familia o cuidadores en el plan terapéutico.
- Fomentar actividad física regular, sociabilización y rutina estructurada.

- Promover sueño reparador y alimentación saludable.
- Evitar aislamiento y promover participación comunitaria.

5.2. Psicoterapia (primera línea en cuadros leves o moderados)

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC):** corrige pensamientos negativos, refuerza actividad y autoeficacia.
- **Terapia interpersonal:** trabaja duelos, conflictos y roles cambiantes.
- **Terapia de reminiscencia:** útil en APS; fomenta memoria autobiográfica y autoestima.
- **Terapia familiar:** favorece apoyo emocional y disminuye sobrecarga.

MINSAL recomienda **TCC y terapia interpersonal** como primeras opciones no farmacológicas.

5.3. Tratamiento farmacológico

Indicado en depresión **moderada o grave**, o cuando hay riesgo suicida.

Fármacos de elección (ISRS):

Fármaco	Dosis inicial	Dosis usual	Observaciones
Sertralina	25 mg/día	50–100 mg/día	Bien tolerada, segura en comorbilidades.
Escitalopram	5 mg/día	10–20 mg/día	Menor interacción medicamentosa.
Citalopram	10 mg/día	20 mg/día	Vigilar QTc prolongado.

Duloxetina 30 mg/día 60 mg/día Útil si hay dolor crónico.

Consideraciones:

- Evitar tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina) por riesgo de arritmias, hipotensión y efectos anticolinérgicos.
- Evitar paroxetina (más sedante y anticolinérgica).
- Iniciar siempre con dosis bajas ("**start low, go slow**").
- Reevaluar respuesta en 4–6 semanas.
- Mantener tratamiento **por al menos 12 meses** tras la remisión.

En depresión resistente o grave:

- Considerar **psiquiatría** para añadir:
 - **Mirtazapina**: útil si hay insomnio o pérdida de peso.
 - **Venlafaxina**: útil en depresión con ansiedad.
 - **Litio o antipsicóticos atípicos** como potenciadores en casos seleccionados.
- **Terapia electroconvulsiva (TEC)**: eficaz y segura en ancianos con depresión psicótica o resistente.

5.4. Manejo del riesgo suicida

- **Evaluar riesgo en cada consulta**: ideación, plan, acceso a medios.
- **Eliminar medios letales**: armas, fármacos, gas.
- **Aumentar supervisión familiar**.
- Derivar a **hospitalización psiquiátrica** si:
 - Intento suicida reciente.

- Plan activo y medios disponibles.
- Depresión psicótica o aislamiento extremo.

□ **Pregunta directa y empática:**

“¿Ha pensado en morir o hacerse daño?” — Preguntar **no aumenta el riesgo**, y puede **salvar vidas**.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Riesgo de suicidio (15% de los casos no tratados).
- Deterioro funcional y cognitivo.
- Aislamiento y pérdida de autonomía.
- Empeoramiento de enfermedades médicas crónicas.
- Mayor riesgo de institucionalización.

6.2. Pronóstico

- Con tratamiento adecuado, **70–80% mejora en 3–6 meses**.
 - Alta tasa de **recaídas** (30–40%), por lo que se requiere seguimiento prolongado.
 - Factores de mal pronóstico:
 - Soledad o falta de apoyo.
 - Enfermedades médicas crónicas graves.
 - Depresión psicótica o con ideación suicida.
 - Abandono del tratamiento.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. En el anciano, la **apatía o lentitud** puede ser el principal síntoma depresivo.
 2. La “**seudodemencia**” mejora con tratamiento antidepresivo.
 3. La **escala GDS-15** es el instrumento de tamizaje más validado en Chile.
 4. **Sertralina y escitalopram** son los antidepresivos más seguros en adultos mayores.
 5. Todo paciente debe ser **evaluado por riesgo suicida en cada control**.
 6. El tratamiento debe mantenerse **≥12 meses tras remisión**.
 7. El **TEC** es seguro y efectivo en depresión grave refractaria.
-



Errores comunes

- Confundir depresión con deterioro cognitivo irreversible.
 - Usar benzodiazepinas crónicamente (riesgo de caídas y confusión).
 - Prescribir tricíclicos o paroxetina en ancianos.
 - No evaluar ideación suicida por “temor a inducirla”.
 - Suspender antidepresivos tras 3 meses de mejoría.
 - Ignorar el impacto de la soledad o el duelo reciente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **depresión geriátrica** es frecuente, subdiagnosticada y puede presentarse sin tristeza evidente.
2. El diagnóstico se basa en **criterios DSM-5** y herramientas como la **GDS-15**.

3. El tratamiento combina **psicoterapia (TCC/TIP)** y **ISRS** (sertralina o escitalopram).
4. Todo paciente debe ser **evaluado por riesgo suicida** de forma sistemática.
5. Evitar **tricíclicos y benzodiacepinas** por sus efectos adversos.
6. La **mirtazapina** es útil en depresión con insomnio o anorexia.
7. El **TEC** es una opción eficaz en depresión grave resistente o psicótica.